

12- Le Coeur_ Résumé et Implication Pratique

On pourrait dire que le cœur, c'est presque le point de rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, dans une symbolique. Ce sera son pattern qui va se mettre, mais ça se met même sur un plan de polarité.

Ensuite, la deuxième fois où on voit apparaître vraiment quelque chose d'intéressant, c'est au niveau de ma ligne primitive. Le vestige en dessous de S2, puisque je sais que S2, c'est la pointe terminale de ma notochorte, donc du lieu de l'ensens, si tu veux. On va le traiter à la fois dans son environnement facial, on va le traiter dans son mouvement développemental. Après, on verra, ça va réintégrer la neurulation secondaire, quand c'est la fermeture et la mise en place du petit bassin. La neurulation secondaire, c'est cet espace entre le phylum terminal et le bourgeon condal, et la partie d'une croissance différentielle de la partie du tube neural par rapport à l'endoblast antérieur, avec une ouverture de la lumière. L'endoblast antérieur, c'est l'endoblast embryonnaire, mais ici, au niveau mésoblastique, mais en même temps, au niveau du cœur aussi. Tu vois ici, je suis dans cette vague avec ma ligne primitive, donc je sais que ceci se terminera en S2. Là déjà, j'ai une force cardiaque primitive, la localisation présumée dans l'épiblaste, ça fait partie du potentiel du cœur. C'est là où je l'ai retrouvé le plus précoce. Épiblaste, l'EDN5, ligne primitive. Des cellules cardiogéniques. Des cellules qui sont au niveau de l'épiblaste. Je vous parle de la couche présomptive de l'épiblaste, donc je n'ai pas encore de méthoderme. On va retrouver cette lame présomptive ici. Regardez le mouvement dans une phase de croissance. Puis je vais avoir ce qu'on appelle la congestion. Et puis j'ai l'intégration et la rencontre de ces deux tubes, qui est organisé de la périphérie par la cavité amniotique. Le tube neural, le tube cardiaque, l'intégration du diaphragme. Pour mettre en place le cœur. Au même moment que j'ai la fermeture de mon tube neural et l'intégration du cellulome externe en un cellulome interne. Moi je me mets sur le lieu le plus précoce que je peux trouver, c'est ma ligne

primitive. Je sais que mon EDN Sense, la notochorde, elle se termine au niveau de S2. Ce que j'ai entre S2 et ma... C'est là où j'ai le vestige de ma ligne primitive. J'ai le fulcrum embryonnaire du cœur sur le coccyx. Donc ici, le cœur, il se met plutôt dans une posture diastolique. Tout de suite, ce que je ressens, c'est que lui, il veut rechercher de l'énergie. Il y a quelque chose qui va le rassurer en fait. Le cœur vient rechercher beaucoup plus de volume ici en dessous. Il redescend dans son mouvement ici. Il y a des fois où il va me montrer un autre point, je ne sais pas. Ça c'est son fulcrum. Deuxième chose, j'ai un mouvement entre le cerveau maintenant, par la céphalisation, et la cardialisation, comme ceci. Le cerveau et le cœur se rencontrent. Au même moment, j'ai une rencontre de mes deux dupes endocardiques sur la ligne médiane. Tu vois, comme ça. Puis j'ai le looping du cœur, comme ceci. Et pour terminer, la mise en place avec le sinusöide du cœur et la crosse, donc les gros vaisseaux, comme ceci. Je prends comme repère mon axe cavale, comme ceci. Dernière chose, sur le cœur, comme ceci. Je regarde si le cœur veut s'exprimer sur un plan en systolique ou en diastolique. Facialement, il recherche plus à diastole ou plus à systole. Puis je peux le mettre par rapport ici, par rapport iliaque. Il cherche beaucoup plus à aller vers une horizontalité, donc il va plutôt vers un mouvement diastolique. Je peux avoir jusqu'à aller rechercher le pouls aortique. Regardez qu'est-ce qui se passe ici. Ici, ici, là. Je vais vous l'intégrer petit à petit, par rapport au mouvement développemental du cerveau. Premier mouvement de développement de mon cerveau, c'était l'expansion. Cette expansion était dépendante de quoi ? De l'axe longitudinal ou de l'axe mésentérique. C'est dépendant de l'intégration vitéline, dont le vestige va se retrouver sur l'axe mésentérique. Ensuite, j'ai un autre niveau qui est important pour nourrir, c'est le système entre la rate et le foie, et puis le retour sur le cœur, cavale. Puis je vais avoir une information aortique, qui va donner une information avec quatre

portes d'entrée, deux portes d'entrée, on va dire. Un carotidien, au-dessus, en dessous, vertébrale. C'est-à-dire qu'on va intégrer, j'ai besoin de vous donner plus d'informations, le développement du cerveau avec le cœur et le système mésentérique. Je vais travailler sur le cerveau et je vais observer quel est le champ qui doit s'ouvrir ou pas. On va voir qu'on peut aller dans des perceptions de plus en plus fines pour déterminer le champ asséché, et voir si on va travailler sur le système carotidien par rapport au cœur, en donnant simplement des points d'appui, qu'elles soient des fulcrums embryonnaires ou simplement des points d'appui dans la construction, pour redynamiser la force de régénération. Tu as un fulcrum, c'est le point d'émergence, et puis tu as toute la force de développement, par exemple l'intégration de ta vésicule viteline dans une artère, ça c'est un vestige, c'est dans la voie développementale, ce n'est pas le fulcrum embryonnaire. C'est entre le fulcrum et la finalité. On commence à voir petit à petit le jeu dans lequel je vais partir, parce qu'après on va travailler sur des artères spécifiques. L'idée c'est de redonner la pleine homéostasie, la pleine électricité, la pleine santé. Je vais toucher son origine de son fulcrum qui va se retrouver de façon indirecte au niveau coccygien, puis qui va s'intégrer petit à petit dans son système ici par le mouvement développemental de manotococcus, cette vague avec cette aspiration au niveau du mésoderme. C'est vraiment ça, c'est ça qu'il faut vraiment sentir. C'est une information qui restructure, redynamise, redonne la force au tissu, redonne la fonction. Le développement des forces embryonnaires, c'est ce qui va permettre le développement de la fonction principale du système. Le grand maître pour tout ça, ce sera notre diaphragme. Ce sera de bien se poser sur ce diaphragme avec trois niveaux. Cavité amniotique sur le plan transversal, thoracique, abdominale, qui est juste cette intégration comme ça, vous vous souvenez, intégration du cellulome, et en même temps l'intégration

du cerveau, du cœur, du diaphragme, la partie postérieure du péritoine pour revenir sur le périnée et redonner par cette bascule du foie toute la fermeture de ma ligne blanche ici qui donnera toute l'information urogénitale. C'est comme ça que ça va se former. Ça veut dire que la ligne blanche ici, là, jusqu'ici, c'est toute l'intégration de ton plan urogénital. C'est l'histoire finale de ton plan urogénital. On va voir qu'il y a une ligne blanche jusqu'ici sur laquelle on va pouvoir aller rechercher des concentrations de temps cristallisées. Parce que c'est une ligne de probabilité. En rapport avec l'érythrocyte, la formation de tes globules, donc un futur, où le plan de la copula, c'est aussi ton futur. Quand tu vas voir que je vais avoir la sortie, comme ceci en fait, au niveau de mes membres, et en même temps l'étiration ici, c'est comme ça que tout le système génital externe, interne, va s'intégrer sur ce plan de ma ligne blanche antérieure. Elle termine pour reconstruire. Sur un plan des globules, l'érythrocytose et ou la gonocytose. Donc je dois avancer. À un moment donné, tu vas voir que l'embryon, il fait un mouvement donc comme ceci. Et puis il y a une ligne d'initiation dans ta vie. C'est au moment où je sors, je dois ouvrir cette ligne. Et j'ouvre cette ligne blanche. Je m'initie à la vie. T'as des gens, ils sont encore fermés sur ce niveau-là. Il y a des enfants qui essaient de s'ouvrir. Mais allez voir ce qui se passe devant. Donc l'idée, ce sera de redonner les justes fulcrums embryonnaires. Le système artériel, il faut le voir comme un octopus. Demain, on va détailler un petit peu plus ce système artériel au niveau du visage, parce que c'est une porte d'accès sur le plan trophique au niveau du cerveau. Il faudra comprendre un petit peu comment se développe ce système carotidien et ce système vertébral. Donc ils sont deux niveaux avec toute l'information sur le polygone de Willis et toute l'information avec la cérébrale antérieure, moyenne, postérieure, les sinus ou les soupapes de Brechet ou de Thierry Goïdienne, etc. qui sont des espaces d'équilibre. On a besoin d'un

équilibre entre l'apport vasculaire et le retour veineux. Et aussi, on sait maintenant qu'il y a un système lymphatique dans le cerveau. Donc pour éliminer ce surplus, il y a certains d'entre vous qui ont une congestion, je peux dire, lymphatique ou veineuse au niveau du cerveau. On le voit chez les gens qui sont un peu gonflés, qui sont un peu, tu vois, un peu édémaciés, etc. On voit que ça ne revient pas. Donc là, on a un travail à faire de rééquilibrage sur le plan veineux, par exemple. Que ce soit sur le plan cavale supérieur ou inférieur. Et ça, c'est assez important parce que sinon, c'est des congestions. C'est tout ce qui est congestion au niveau des oreilles. C'est tout ce qu'on n'arrive pas à sortir, tu vois. Donc je me mets bien au niveau du coccyx et au niveau du cœur. Vous mettez l'angle de Louis, tronc vasculaire de type aortique pulmonaire, là. J'ai ici le cœur. Je vous rappelle que le cœur, il est sur l'axe longitudinal. Ce n'est qu'une partie de lui qui est dilatée vers la gauche. Il est sur l'axe longitudinal. Mais avec une phase de développement sur sa pointe du cœur à gauche. Donc vous allez vous mettre sur le plan longitudinal du cœur, comme ceci. Et vous allez juste sentir, en donnant un fulcrum ici, et un point d'appui sur le cœur. Mon attention est dans l'espace. Neutre, espace, et on laisse le système s'organiser.